Súbežné užívanie inhibítorov protónovej pumpy (PPI) a agonistov GLP-1 môže zvyšovať gastrointestinálne nežiaduce účinky

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Obe liečby spomaľujú trávenie po svojom — spolu sa ich účinok sčíta.

Ak užívate liek z triedy agonistov GLP-1 (napr. pri diabete 2. typu alebo obezite) a zároveň máte nasadené PPI (na reflux, pálenie záhy alebo „žalúdočnú ochranu“), možno vás zaujíma, či tieto lieky nemôžu v kombinácii zhoršovať tráviace ťažkosti. Nová analýza z výskumnej siete TriNetX naznačuje, že áno — a čísla sú pomerne výrazné.

Čo ukázala nová analýza (TriNetX, SGIM 2026)

Podľa informácií z Medscape ide o výsledky prezentované na konferencii SGIM 2026, založené na analýze dát z výskumnej siete TriNetX za dlhšie obdobie.

Hlavné zistenia:

- Pacienti, ktorí užívali **agonistu GLP-1 aj PPI súčasne**, mali **viac než dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť** výskytu nežiaducich účinkov v hornej časti tráviaceho traktu oproti skupine užívajúcej iba GLP-1 (RR 2,37; 95 % IS 2,30–2,44; $p < 0,001$).
- **Nevoľnosť a vracanie**: približne **1,8×** častejšie (RR 1,81; 95 % IS 1,75–1,88; $p < 0,001$).
- **Tráviace ťažkosti (indigestion)**: približne **3,5×** častejšie (RR 3,50; 95 % IS 3,28–3,75; $p < 0,001$).
- Častejšie sa uvádzali aj komplikácie, napríklad **akútna pankreatitída** a **žlčníkové kamene** (uvádzané ako zvýšené riziko; priame príčiny sa z dát nedajú jednoznačne uzavrieť).
- Zaznamenali sa tiež rozdiely v nižších častiach tráviaceho traktu: **hnačka, zápcha** a **spomalenie črevnej peristaltiky**.
- Pacienti v kombinácii liekov mali podľa analýzy aj **vyššiu potrebu vyšetrení** typu horná endoskopia.

Dôležitý kontext: išlo o porovnanie skupín v reálnych dátach. Čísla popisujú asociáciu, nie priamy dôkaz, že PPI konkrétne „spôsobuje“ zhoršenie pri GLP-1.

Prečo treba byť opatrný v interpretácii

V článku zaznelo viacero dôvodov na opatrnosť:

- Dátam z tejto siete chýbajú detaily o tom, **prečo** bol PPI nasadený (napr. či pacient mal už predtým reflux, dyspepsiu, vredové ochorenie alebo príznaky z tráviaceho traktu).
- Nejde o úplne homogénne skupiny — môžu sa líšiť aj typom GLP-1 lieku a tým, či pacient mal tráviace ťažkosti už pred začiatkom GLP-1.
- GLP-1 samotné často spôsobujú gastrointestinálne príznaky (nevoľnosť, vracanie, spomalené vyprázdňovanie žalúdka), ktoré sa môžu klinicky podobať na refluxové ochorenia.

Jednoducho povedané: štúdia dáva signál, že kombinácia sa v praxi spája s vyšším výskytom ťažkostí, ale neumožňuje definitívne tvrdiť kauzalitu.

Čo to znamená prakticky pre pacienta

Ak máte agonistu GLP-1 a PPI a objavili sa alebo sa zhoršili tráviace príznaky (pálenie záhy, nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, výrazná zápcha, príznaky zhoršeného trávenia), je rozumné:

1. **Nezvyšovať lieky „na vlastnú päsť“** a nemeniť režim bez dohody s lekárom.
2. **Prekonzultovať, či PPI potrebujete** a v akej dĺžke. V článku sa spomína tendencia k „depreskribovaniu“ PPI, keď to klinicky dáva zmysel.
3. Ak by príznaky pretrvávali alebo boli výrazné, lekár môže zvážiť ďalší postup, vrátane toho, že symptomatológia pri GLP-1 môže vyžadovať úpravu liečby alebo ďalšie vyšetrenie.

Z nefrologického hľadiska má pri výrazných gastrointestinálnych ťažkostiach význam aj prevencia dehydratácie. Opakované zvracanie alebo výrazná hnačka môže nepriamo zvyšovať riziko zhoršenia hydratácie a následne aj renálnych parametrov, najmä u rizikových pacientov (napr. s chronickou chorobou obličiek). Toto nie je priamy záver štúdie — ide o bežnú klinickú opatrnosť pri takýchto symptómoch.

Odporúčanie pre klinickú prax

Ako to z článku vyplýva:

- Uvažovať o **systematickom zhodnotení indikácie PPI** u pacientov na GLP-1, najmä ak sa objavili nové alebo zhoršené gastrointestinálne symptómy.
- Nepracovať s automatizmom, že PPI je „bezpečné“ bez kontroly dĺžky terapie — treba priebežne vyhodnocovať potrebu pokračovania.
- Zároveň však nie je vhodné vyvolať strach tak, že by sa potrebná liečba refluxu úplne odmietala. Ak má pacient pálenie záhy a klinické dôvody pre terapiu, liečba sa má **individualizovať**.

Zhrnutie

Reálne dáta naznačujú, že **pacienti na GLP-1 spolu s PPI** majú častejšie gastrointestinálne nežiaduce účinky a vyššiu potrebu vyšetrení. Ide o asociáciu s metodickými limitmi, preto je kľúčové individualizované prehodnotenie liečby a indikácie PPI — nie plošné vysadenie, ale informovaný rozhovor s lekárom.

Zdroj: *Medscape – „Concurrent Proton Pump Inhibitor, GLP-1 Use Linked to Increases in GI Events“.* *Link na zdroj.*

Upozornenie: *Tento článok bol osobne spracovaný aj s pomocou rozličných nástrojov tzv. umelej inteligencie (AI).*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=subezne-uzivanie-ppi-a-glp-1-gastrointestinalne-neziaduce-ucinky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.